

- ヘパリン、ワルファリンの他、直接作用型抗凝固薬 (direct oral anticoagulant: DOAC) のうちリバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバンは急性肺血栓塞栓症に対する適応を有する。
- ✕ 抗血小板薬は急性肺血栓塞栓症の治療とならない。
- 心拍出量低下、低血圧例に対するカテコラミンは 2017 年の肺血栓塞栓症のガイドライン(日本循環器学会) でもクラス IIa として推奨されている。
- ショックを伴う重症例は血栓溶解療法の適応となるが、出血の合併症に注意する必要がある。我が国で保険適応があるのはモンテプラゼ (tissue-plasminogen activator: t-PA) のみである。
- ✕ カテーテル治療は様々な内科的治療を行ったにもかかわらず不安定な血行動態が持続する患者が適応であり、初期治療として選択することは適切でない。

- 1997 年に年間 506 人、2012 年には 1,162 人との報告がある一方で、2006 年の厚生労働省のアンケート調査では年間 14,674 人と推計されたものもあり、増加傾向である。
- ✕ 膝窩静脈より中枢型のものが中枢型、膝窩静脈以遠が末梢型とされる。
- 逆に臨床的に高確率の場合は、血清 D-dimer 値が正常であっても否定はできない。
- 左総腸骨静脈が右総腸骨動脈に圧迫されるためといわれている。
- アピキサバンを含む DOAC は初期治療から用いることができる。
- ✕ 2 週間以内に中枢進展がなければその後の進展はないとされ、無症候性で低リスクの場合は経過観察が選択される。

10